

CAPÍTULO 7.10

Enfermedad de Basedow-Graves Neonatal

PERFIL EUNACOM 1.03.2.009

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Enfermedad de Graves Neonatal

Mecanismo

La madres con Graves tiene anticuerpos **TRAb (TSI)** que cruzan la placenta → estimulan la tiroides del feto/neonato → **hipertiroidismo transitorio neonatal**.

- Es **transitorio**: los TRAb maternos se eliminan en semanas (vida media ~3 semanas)
- Desaparece espontáneamente al aclararse los anticuerpos

Cuándo sospechar

- Madre con antecedente de **Graves-Basedow** (activo o pasado)
- Recién nacido con signos de hipertiroidismo

Clínica del Neonato

- Taquicardia, irritabilidad, temblor
- Exoftalmos
- Bocio neonatal
- Baja de peso, dificultad para alimentarse
- Puede comprometer el desarrollo neurológico si no se trata

Diagnóstico

- Confirmar con TRAb maternos elevados + TSH + T4 libre neonatal
- TSH ↓ + T4 libre ↑ con clínica → confirma Graves neonatal

Tratamiento

- **Antitiroideos** (PTU o MMI) hasta aclaramiento de anticuerpos
- **Propranolol** si taquicardia severa
- Expectante: mejora espontáneamente en semanas

EUNACOM CRITERIOS

La severidad en el neonato depende de los niveles de TRAb maternos. A mayor TRAb → mayor riesgo de Graves neonatal severo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Recién nacido de 5 días de vida, hijo de madre con Enfermedad de Basedow-Graves tratada con tiroidectomía hace 2 años, presenta taquicardia persistente (FC 190 lpm), irritabilidad, pobre ganancia ponderal, ojos prominentes y bocio palpable."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Enfermedad de Basedow-Graves Neonatal: causada por el paso transplacentario de anticuerpos maternos estimulantes del receptor de TSH (TRAb de tipo IgG). Puede ocurrir incluso si la madre ya fue operada o tratada con yodo radioactivo. Es un cuadro autolimitado que dura 2-3 meses (mientras se eliminan los anticuerpos maternos). Tratamiento agudo: Metimazol + Propranolol + Solución de Lugol para frenar la liberación hormonal.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Los TRAb maternos pasan la barrera placentaria y pueden causar hipertiroidismo neonatal transitorio (4-12 semanas).
- El nivel de control materno no se correlaciona necesariamente con los niveles de anticuerpos en el feto.
- Manejo: medir TRAb + pruebas tiroideas al recién nacido.
- TRAb negativos = bajo riesgo. TRAb positivos = repetir en 10-15 días.
- Si hipertiroidismo neonatal confirmado: betabloqueo + metimazol durante el periodo transitorio.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDAD DE BASEDOW-GRAVES NEONATAL)

PREGUNTA 1

Recién nacido hijo de madre con enfermedad de Basedow-Graves. Se solicitan TRAb al neonato que resultan positivos. ¿Cuál es la conducta inmediata?

- A)** Iniciar metimazol inmediatamente
- B)** Repetir exámenes en 10-15 días
- C)** Tiroidectomía neonatal
- D)** Yodo radioactivo
- E)** No hacer nada, el hipertiroidismo neonatal no existe

RESUMEN: ENFERMEDAD DE BASEDOW-GRAVES NEONATAL

La enfermedad de Basedow-Graves neonatal ocurre cuando los anticuerpos TRAb de la madre pasan al feto a través de la barrera hematomplacentaria, pudiendo generar hipertiroidismo neonatal transitorio que dura 4-12 semanas (lo que duran los anticuerpos). El manejo se basa en medir TRAb al recién nacido independientemente del control de la enfermedad materna. Si TRAb negativos: bajo riesgo. Si TRAb positivos: repetir exámenes en 10-15 días y si hay hipertiroidismo clínico o de laboratorio, tratar con betabloqueo + metimazol.